

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ “เบิกยาได้ครบ ต้องจบที่เรา”

2. ผลงานประเภท : Poster presentation (CQI)

3. คำสำคัญ : การเบิกจ่ายยา,การสำรองยา,คลังยา

4. สรุปผลงานโดยย่อ : คลังยาเป็นหน่วยงานที่สำรองยาสำหรับห้องจ่ายยาทุกห้องเพื่อบริการจ่ายยาให้ผู้ป่วย โดยห้องจ่ายยาจะเบิกยาไปสำรอง ณ จุดบริการสัปดาห์ละครั้ง จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังเดือนมกราคม - มีนาคม พบว่า ยาสำรองคงคลังมีไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายจำนวน 91, 65 และ 72 รายการ ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 6.80, 5.07 และ 4.34 ของรายการยาที่เบิกทั้งหมด โดยเดิมห้องจ่ายยา จะระบุรายการยาที่เบิกไม่ได้ หรือเบิกได้ไม่ครบจำนวนลงในไลน์กลุ่ม เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน แต่เนื่องจากการสื่อสารในลักษณะนี้ยังคงเกิดความคลาดเคลื่อน และได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน จากปัญหาดังกล่าว งานคลังยา จึงวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข และพัฒนาจัดทำแบบบันทึกในรูปแบบ Google sheets เพื่อบันทึกรายการยาที่พบปัญหาทั้งหมดอย่างเป็นระบบ และสามารถนำมาสรุปรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน เพื่อนำไปปรับจำนวนจุดสั่งซื้อ หลังดำเนินการพบว่า อัตราการเบิกยาไม่ได้/ได้ไม่ครบ ลดลงเหลือร้อยละ 5.69, 4.65 และ 1.64 ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ (ไม่เกิน 2%) ส่งผลให้เกิดการสำรองยาคงคลังอย่างเพียงพอต่อไป

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้งานคลังยา รวบรวมข้อมูลรายการยาที่ห้องจ่ายยาเบิกไม่ได้ หรือได้จำนวนยาไม่ครบได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อลดอัตราการเบิกยาไม่ได้หรือได้ไม่ครบถ้วนเหลือไม่เกินร้อยละ 2
3. เพื่อปรับปรุงจุดสั่งซื้อ (Min-Max) ให้สอดคล้องกับอัตราการใช้จริง ป้องกันทั้งปัญหาขาดและการสำรองยาเกินความจำเป็น

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : การบริหารจัดการคลังยาและการสำรองยาให้เพียงพอ คือ หัวใจสำคัญของระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากอัตราการใช้ยาในแต่ละช่วงเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงไปจากหลายสาเหตุ เช่น โรคระบาดตามฤดูกาล แนวทางเวชปฏิบัติใหม่ในแต่ละปี หรือจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นแตกต่างกันในแต่ละช่วง การปรับการสำรองยาให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจึงเป็นปัญหาที่ท้าทาย และเป็นบริบทหลักของงานคลังยา โครงการนี้จึงจัดทำขึ้น เพื่อให้งานคลังยาสามารถรวบรวมรายการยาที่มีอัตราการใช้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลไปปรับอัตราการสำรอง จำนวนจุดสั่งซื้อ และแจ้งจัดซื้อจัดหาล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันปัญหาขาดไม่เพียงพอต่อการบริการผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวปรับลดอัตราการสำรองยาที่มีการใช้ลดลง ให้มีการสำรองอย่างเหมาะสม เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

7. กิจกรรมการพัฒนา :

1. ประชุมร่วมกันภายในคลังยา เพื่อวิเคราะห์รวบรวมสาเหตุของปัญหาและวางแผนโครงการ
2. จัดทำแบบบันทึก google sheets สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลรายการยาที่พบปัญหาการเบิกจ่าย พร้อมทั้งระบุสาเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลในการสื่อสารและติดตามแก้ไข
3. นำข้อมูลจาก Google Sheets มาวิเคราะห์เพื่อปรับอัตราการสำรองและจุดสั่งซื้อ (Min-Max Stock)
4. เก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2569 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารคลังยาอย่างต่อเนื่อง

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

1. อัตราการเบิกยาไม่ได้/ได้ไม่ครบถ้วน ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายการเบิกทั้งหมด
2. ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลปัญหาขาดผ่าน Google Sheets คิดเป็นร้อยละ 100
3. อัตราที่ผู้ป่วยได้รับยาไม่ครบถ้วนเนื่องจากปัญหาขาด ณ จุดจ่ายยา เท่ากับ 0%

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

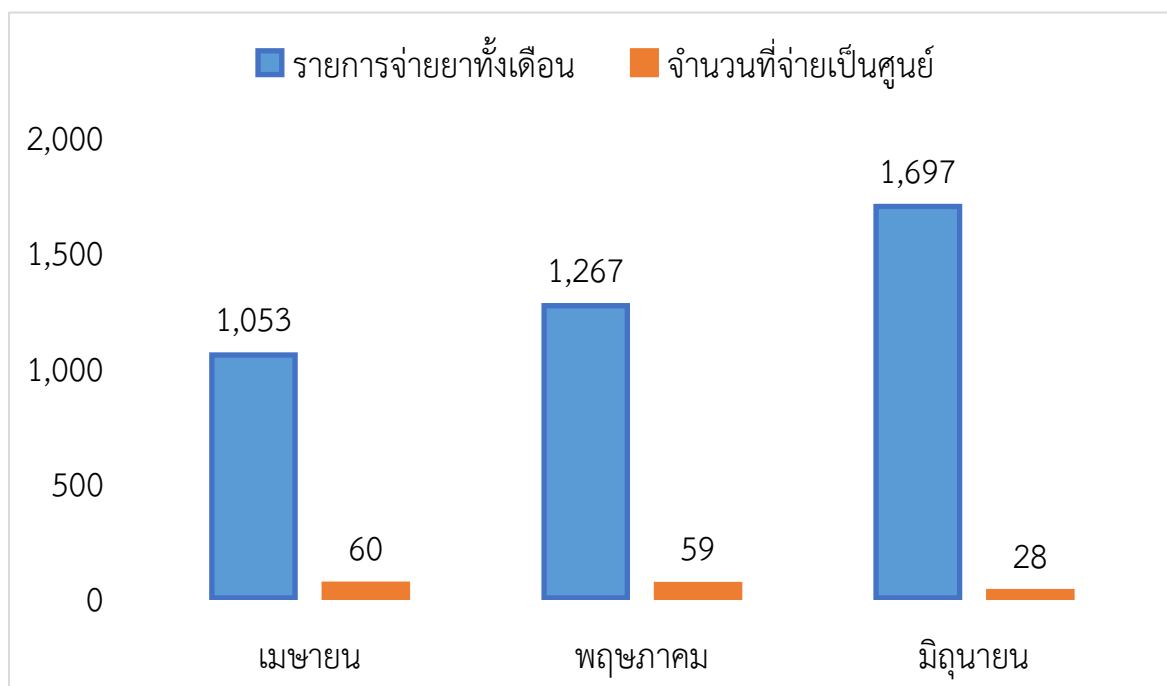
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงคือการตรวจสอบใบฎีกาจ่ายยาที่จ่ายแต่ละห้องนำมารวบรวมข้อมูลลง Google Sheets พบว่าร้อยละของจำนวนรายการยาที่เบิกไม่ได้ลดลงจากเดิมตามลำดับและได้ปรับจำนวนจุดสั่งซื้อ (Min-Max) ให้เหมาะสมกับอัตราการการใช้

ลำดับ	รายการยา	เดือนเมษายน 69				เหตุผล			
		OPD-2	OPD-11	IPD	รวม	รอจัดซื้อ	เบิกได้ไม่ครบแก้ไขตามใบเบิก	ไม่มีของส่ง	หมายเหตุ
1	ADENOCOR INJ 6mg/2ml =ส=***			1	1	1			
2	ASMASAL SDU NEB 2.5 MG,2.5 ML=ส=	1			1	1			
3	BACIN (bactrim) INJ 80+400mg/5ml =ส=			1	1	1			
4	BACTIGRAS PATCH 10x10 cm (\$)	1			1	1			
5	BETAMETHASONE CREAM 0.1%, 5 GM	4	3		7			7	gpoไม่มีของเปลี่ยนไปใช้ของเภสัชกรรมทหาร
6	CIFLOXIN TABS 250 mg		1		1	1			
7	CONCERTA TAB 27 mg (\$)	3	1		4			3	อย.จัดสรร
8	CONCERTA TAB 18 mg (\$)	1			1			1	อย.จัดสรร
9	CONCERTA TAB 36 mg (\$)	1			1			1	อย.จัดสรร
10	DITERIN(BH4) TAB 100 mg (พ/จ.2)	1			1	1			
11	DOBUTEL INJ 5 ml, 250mg/5ml=ส= ***			1	1	1			
12	DUCTACLOSE=ส=(indomethacin) INJ 1 mg			1	1	1			gpo
13	ESLORAY SYR 0.5mg/ml,60ml @(\$)	1	1		2			2	ยาตัวอย่าง
14	EUTHYROX TAB 50 mcg =ส=		1		1	1			
15	EUTROPIN (\$) INJ 4 IU/ML, 1ML		1		1		1		
16	GPO CBD OIL 100mg/ml,10ml	1			1		1		อัตราการใช้ลดลง
17	HALOPERIDOL (Polyhadon) TAB 0.5 mg		2		2	2			
18	HAVRIX 720 INJ 0.5 ML#		1		1			1	แจ้งของขาดถึงก.ย.69ใช้vovaximแทน
19	HRIG-Human INJ 300Unit/2ml	2			2	2			กาขาด
20	HYSONE (CORTEF) TABS 10 mg =ส=			1	1	1			gpo
21	IMMUCEPT CAPS 250 mg (MMF)		1	1	2	2			
22	LANOXIN INJ 0.5 MG/2ML=ส=***			1	1			1	ขาดถึงม.ย.69
23	LEUCO-PLUS(GCSF) 300 mcg/1ml =ส=	1			1	1			
24	LOPERAMIDE TAB 2 mg (MANTIL)	2		3	5			5	
25	MOBINUL INJ 0.2mg/1ml			1	1	1			
26	M-PREDNISOLONE INJ 500mg =ส=			1	1	1			
27	NEOSTIGMINE INJ 2.5MG/ML 1 ML=ส=			1	1	1			gpo
28	PERMETHRIN CREAM 1%/20กรัม (Hecin)=เทา=		1		1		1		
29	PO-TRIM TAB 80/400 mg =ส=	3			3			3	ของเข้าต้นเดือน พค.69
30	PREVNAR 20 INJ 0.5 mL (PCV20)##	1		1	2	2			
31	PROPYL (PTU) TAB 50 mg	1			1	1			
32	PROTAMINE SULFATE INJ 10 MG/ML,5 ML			2	2			2	ยาขาดคราว
33	RIFAMCIN CAPS 450 mg =ส=		2		2	2			

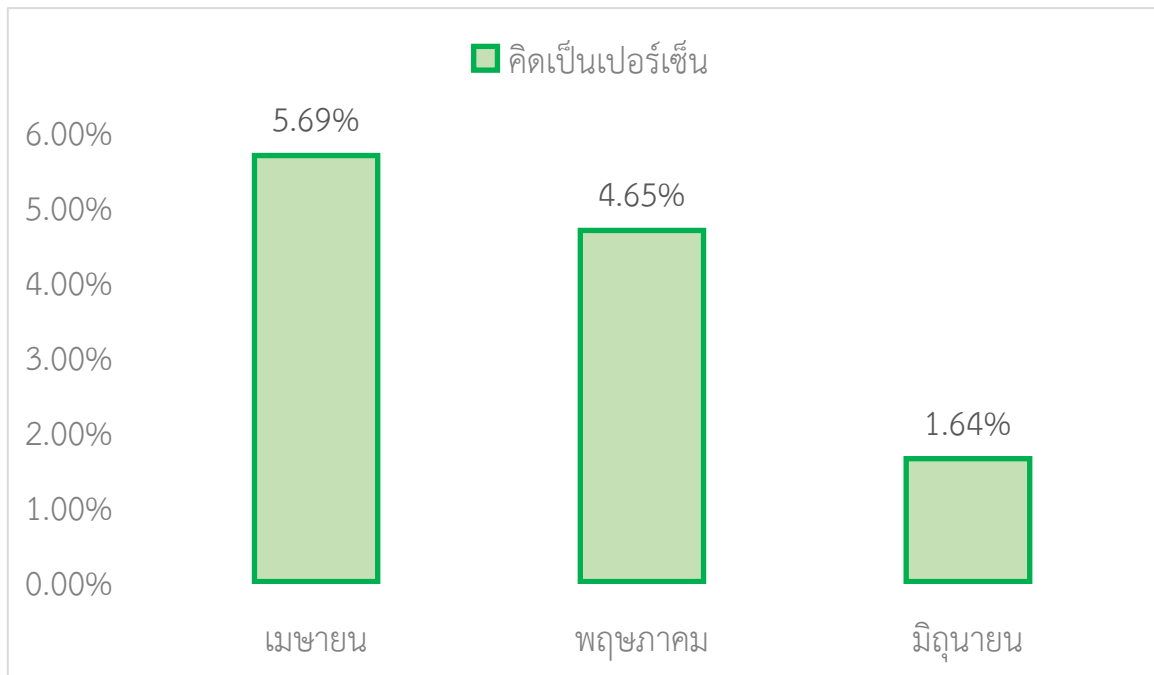
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง

หลังจากการปรับ Min-Max Stock พบว่าอัตราการเบิกยาไม่ได้/ได้ไม่ครบ มีการลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือร้อยละ 1.64 ในเดือนมิถุนายน 2569 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ไม่เกินร้อยละ 2) ดังรูป1-2

รูปที่1 : แสดงจำนวนรายการยาที่จ่ายทั้งเดือน และ จำนวนรายการยาที่จ่ายเป็นศูนย์



รูปที่2 : แสดงจำนวนร้อยละของรายการยาที่จ่ายเป็นศูนย์



10. บทเรียนที่ได้รับ :

- ปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน พบว่ายาบางชนิดมีผู้จำหน่ายรายเดียวหรือปัญหาขาดครว ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปริมาณการสำรองแล้ว ยังต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการในการจัดหาทดแทนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างเหมาะสม
- มีการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ คือ Google sheets มาใช้เก็บรวบรวมและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้จากเดิมที่ใช้การจดบันทึกจากข้อมูลในไลน์กลุ่ม
- รายการยาบางรายการมีอัตราการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมจึงต้องพิจารณาปรับปรุงจำนวนจุดสั่งซื้อใหม่

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

- 1.นางสาวนพพรช เทียมสุขสม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
 - 2.นางสาวเพ็ญฤทัย สิทธิสระ นักวิชาการพัสดุ
- ที่ปรึกษา เภสัชกรหญิงนพมาศ ภูทับทิม
หน่วยงานคลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม เบอร์โทรศัพท์ 2306 และ psittisra@gmail.com